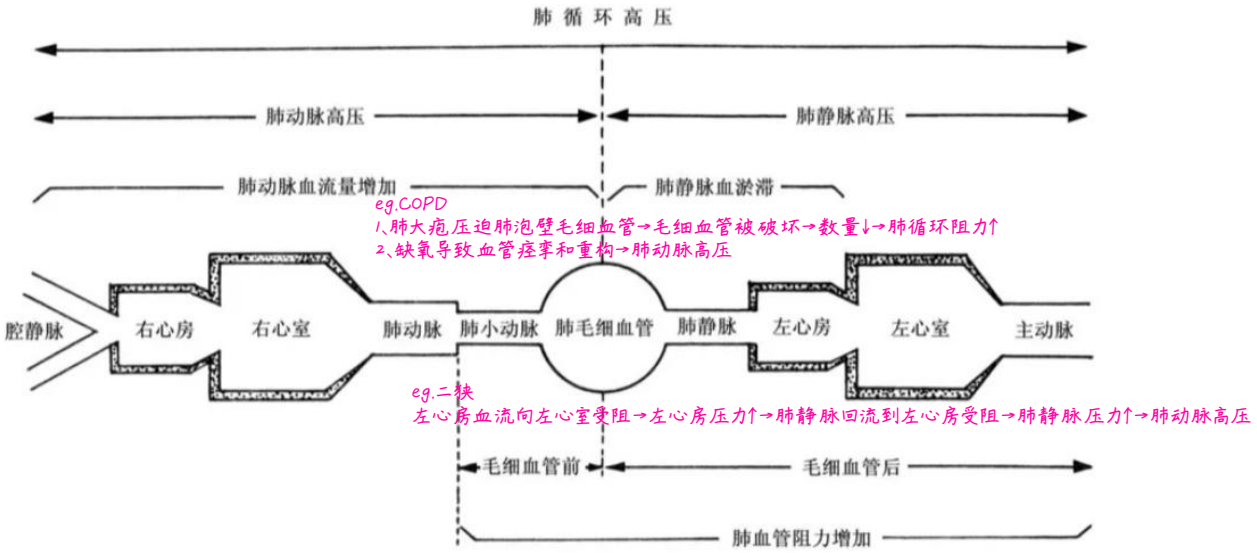
内科学含诊断学 呼吸系统疾病

核心精讲·肺动脉高压

（性感认识：治肺不治心）

肺动脉高压→右心射血后负荷↑→右心室功能障碍，心脏的问题由肺导致，所以治疗的重点在肺，心脏的问题随肺解决

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图



无肌型细动脉肌化、肌型小动脉中膜增厚、内膜下出现纵行平滑肌束、小动脉炎、小动脉胶原纤维增生、腔内血栓形成和机化、肺泡间隔毛细血管数量减少

一、慢性肺源性心脏病

（一）临床表现

正常情况：先A2再P2，且无法分辨A2P2
肺动脉压力↑→右心室后负荷↑→（蓄力时间↑）右心射血时间↑→肺动脉关闭延迟→A2P2就分开了（通常分裂）

1.**缺氧致血管痉挛和重构→肺动脉高压**

S2 ┌ A2 主动脉压力↑→A2↑
　 └ P2 肺动脉压力↑→P2↑

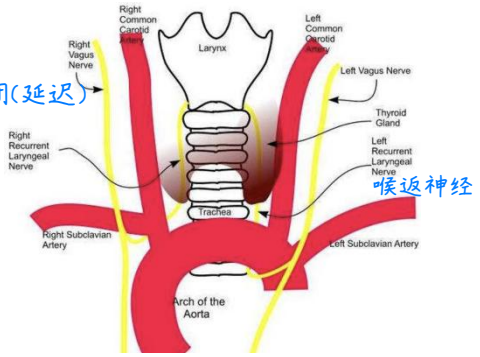
先主动脉瓣关闭→再肺动脉瓣关闭（延迟）

A2　P2　P2'（延迟）

通常分裂

（1）**P_2亢进及通常分裂**

（2）Ortner综合征（心脏-声带综合征）
肺A/左心房/主A增大压迫左侧喉返神经
eg.肺A高压、二尖瓣狭窄、高血压



2.代偿期和失代偿期均可有 怒伤肝

（1）颈静脉怒张　又吸气又吸血，现在负值↓就不能吸血了 =-肺回缩压

①代偿期：肺气肿→胸腔负压 ttsx 负值↓→腔静脉回流↓

②失代偿期：肺气肿+右心功能不全

（2）剑突下/三尖瓣区收缩期杂音　胸骨左缘四五肋间

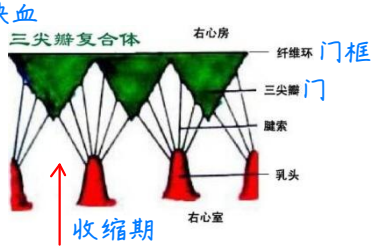
①代偿期：右心室肥厚（**心前区/剑突下抬举样搏动**）→乳头肌功能障碍　常提示心脏动力↑　肺心病乳头肌和肉柱显著增厚，但血供跟不上→相对缺血

向心性肥厚

→三尖瓣相对关闭不全→三尖瓣区收缩期杂音（收缩期三尖瓣关闭）

②失代偿期：右心室扩大→**三尖瓣相对关闭不全→三尖瓣区收缩期杂音**

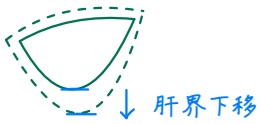
"门框"变大，"门"还是那么大



（3）肝界下移

①代偿期：肺气肿 膈肌下移

②失代偿期：肺气肿+右心功能不全 肝脏淤血肿大



鉴别肝界下移是代偿期还是失代偿期

↓

痛不痛 ┌ 肺气肿肝区无疼痛
　　 └ 右心衰肝区有疼痛（刺激包膜神经）